

Непосредственные результаты паллиативных гастрэктомий при распространенном раке желудка

Бакиров Н.Д., Тайлаков Б.Б.

Национальный Центр Онкологии при Министерстве Здравоохранения Кыргызской Республики

УДК: 616.33-006.6-089:615.036

Кыргыз Республикасынын Денсаулык сактау Министрлигинин жанындагы Ұлттық Ғылыми Онкологиялық орталыгында 1984 жылдан 2005 жылдары аралыгында, асқазанның қатерлі ісігінің жайылған түріне шалдыққан 100 науқасқа жасалынған паллиативті гастрэктомияның кәдуелгі және кеңейтілген-күрделене оташылдық емнің тікелей нәтижелерінің салыстырмалы сараптамасы авторлармен ұсынылады.

Барлық науқастарға жасалған ота көлемі – гастрэктомия. Кәдуелгі ота көлемі өткізілгені – 41, ал кеңейтілген-күрделенгені 59. Паллиативті гастрэктомияның ота емінен кейінгі асқынулары іріңді қабыну, орталық немесе шеткері қан айналымының бұзылыстары, жіңішке немесе тоқ ішектерінің жыланкөздерінен кейінгі перитониттің дамуы авторлардың мәліметі бойынша 28 науқаста, ал пайыздық бойынша 28%-і тіркелді. Паллиативті гастрэктомиядан кейінгі осы асқынулары, кәдуелгі гастрэктомиядан кейін 23,7±5,5%, ал кеңейтілген отадан кейін 34,1±7,4% болды. Келтірілген мәліметтер бойынша асқынулардың айтарлықтай өзгерістері жоқ.

Оташыл емнен кейінгі 100 науқастан 8-і қайтыс болды, өлім көрсеткіші - 8% болды. Атап өтуге болатыны паллиативті ота емінен кейінгі өлім көрсеткіші радикалды ота жасалған науқастармен еш айырмашылығы жоқ. Оташылдық асқынулары жартысында өлімге әкелуі себебі болса, қалғандарында функционалды асқынулар.

Кәдуелгі паллиативті гастрэктомиядан кейінгі өлім көрсеткіші 4,9±3,4%, ал кеңейтілген-күрделенген 10,2±3,9%. Осы алынған мәліметтерді сараптай отырып, кеңейтілген-күрделенген ота емінен кейінгі өлім көрсеткіші, кәдуелгі гастрэктомиядан айтарлықтай айырмашылығы болмады.

Сонымен, арнайы клиникалар жағдайында өткізілген ота, кәдуелгі және кеңейтілген-күрделенген паллиативті гастрэктомиялар асқыну жиілігі мен өлім көрсеткіші құрылын өзгертпейді, өз-өзін ақтайды.

Непосредственные результаты паллиативных гастрэктомий при распространенном раке желудка

Н.Д. Бакиров, Б.Б. Тайлаков

Авторами приводится сравнительный анализ паллиативных гастрэктомий между стандартными и расширенно-комбинированными вмешательствами непосредственных результатов лечения 100 больных распространенным раком желудка оперированных в Национальном Центре Онкологии при Министерстве Здравоохранения Кыргызской Республики за период с 1984 по 2005 гг..

Всем больным произведено оперативное вмешательство в объеме гастрэктомии. Операция в стандартном объеме выполнена 41 больному, расширенно-

Direct results of palliative gastrectomy at widespread gastric cancer.

N.D.Bakirov, B.B.Tajlakov

Authors show the results of comparative analysis of palliative gastrectomy between the standard and wide-combined interventions of direct results of treatment of 100 stomachs sick by a widespread cancer operated in the National Center of Oncology at Ministry of Health of the Kirghiz Republic from 1984 on 2005.

All patients make operative intervention in gastrectomy. Operation in standard volume is executed to 41 patients, wide-combined - 59. Postoperative complications at palliative gastrectomy a kind inflammatory, infringements of the central and peripheral blood circulation also it is intestinal fistulas with development of peritonitis according to authors were observed at 28 patients that has made 28 %. The given complications at palliative gastrectomy have made 23,7±5,5 % at standard gastrectomy and 34,1±7,4 % at the expanded. From the presented data it is visible that an essential difference in frequency of complications practically it is not revealed.

From 100 operated patients 8 have died, postoperative mortality has made 8,0 %. It is necessary to notice that postoperative mortality at palliative gastrectomy essentially does not differ from postoperative mortality considerably operated patients. The reasons of lethal outcomes in half of cases were surgical complications, in other cases functional complications.

Mortality after standard palliative gastrectomy has made 4,9±3,4 %, and after wide-combined - 10,2±3,9 %. Analyzing this data, it is possible to tell that the wide-combined operations are not accompanied by substantial growth postoperative mortality in comparison with standard gastrectomy.

Thus, standard and wide-combined palliative gastrectomy do not increase frequency of postoperative complications and mortality, do not change their structure that does justified performance such operations in the conditions of specialized clinics.

комбинированные - 59. Послеоперационные осложнения при паллиативной гастрэктомии виде воспалительной, нарушений центрального и периферического кровообращения и тонко-, толстокишечные свищи с развитием перитонита по данным авторов наблюдались у 28 больных, что составило 28%. Данные осложнения при паллиативных гастрэктомиях составили 23,7±5,5% при стандартных гастрэктомиях и 34,1±7,4% при расширенных. Из представленных данных видно, что существенной разницы в частоте осложнений практически не выявлено.

Из 100 оперированных больных умерли 8, послеоперационная летальность составила 8,0%. Следует отметить, что послеоперационная летальность при

паллиативных гастрэктомиях существенно не отличается от послеоперационной летальности радикально оперированных больных. Причинами летальных исходов в половине случаев являлись хирургические осложнения, в остальных случаях функциональные осложнения.

Летальность после стандартных паллиативных гастрэктомий составила $4,9 \pm 3,4\%$, а после расширенно-комбинированных – $10,2 \pm 3,9\%$. Анализируя эти данные, можно сказать, что расширенно-комбинированные

К настоящему времени хирургия остается ведущим методом лечения рака желудка и ей присущи большое количество нерешенных проблем. Важными задачами метода являются разработки рациональных методов лечения, снижающих частоту послеоперационной летальности и уменьшение числа осложнений, которые являются препятствиями внедрения в хирургическую практику расширенных и комбинированных операций, обеспечивающих, безусловно, большой радикализм по сравнению с рутинными резекциями. Вместе с тем, большие объемы и зачастую расширенный, комбинированный характер хирургического вмешательства, распространенность опухолевого процесса, в основном пожилой возраст больных и, как правило, наличие различных сопутствующих заболеваний обуславливает сложность обеспечения благоприятных непосредственных результатов. В тоже время, по мнению некоторых авторов, сужение показаний к операциям большого объема и большей радикальности неоправданно обрекает больных на гибель от прогрессирующего и рецидивирующего рака [3, 9, 10, 11].

Частота выполнения паллиативных гастрэктомий, по данным разных авторов [6, 7, 12, 15, 16], составляет от 2,5 до 48%. Такой разброс данных свидетельствует об отсутствии единого мнения в отношении паллиативных гастрэктомий. До сего времени вопрос о целесообразности таких операций остается спорным. Негативное отношение к расширению объема оперативных вмешательств связано с непосредственной опасностью и данными об отдаленных исходах. Анализ литературы показывает, что если у одних авторов отмечаются высокие проценты послеоперационной летальности, то другие имея удовлетворительные результаты, рекомендуют расширять показания к паллиативным гастрэктомиям. Послеоперационные осложнения при паллиативной гастрэктомии по данным этих авторов варьируют от 11 до 38%, а летальность от 3,5 до 13% [1, 2, 5, 8, 13, 14, 17].

Основной целью хирургического вмешательства при распространенном раке желудка является избавление больного от осложнений опухолевого процесса. Вторая цель операции заключается в уменьшении опухолевой массы (циторедукция) как для снижения симптомов опухолевой интоксикации и улучшения качества жизни, так и для более успешного проведения последующей лекарственной терапии. В-третьих, паллиативные гастрэктомии способствуют максимальному увеличению продолжительности жизни. Следует иметь в виду, что наличие отдаленных метастазов, как правило, сочетается со значительным местным и регионарным распространением опухоли, т.е. зачастую объем операции возрастает до комбинированного вмешательства с расширенной лимфаденэктомией. В то же время запущенный опухолевый процесс неизбежно связан с истощением больного, наличием анемии, гипопропротеинемии, водно-электролитными нарушениями [4, 9, 11].

Таким образом, принятие решения о выполнении паллиативной гастрэктомии весьма сложны и ответственны для хирурга в связи с необходимостью учитывать как потенциальные преимущества, так и высокий риск развития после-

операции не сопровождаются значительным увеличением послеоперационной летальности по сравнению со стандартными гастрэктомиями.

Таким образом, стандартные и расширенно-комбинированные паллиативные гастрэктомии не увеличивают частоту послеоперационных осложнений и летальность, не изменяют их структуру, что делает оправданным выполнение таких операций в условиях специализированных клиник.

операционных осложнений, в том числе летальных.

Материалы и методы

В основу проведенных исследований положен анализ результатов лечения 100 больных раком желудка, оперированных в НЦО МЗ КР за период с 1984 по 2005 гг. Среди пациентов преобладали мужчины: 66 (66,0%) против 34 (34,0%) женщин, соотношение 1,94:1. Средний возраст больных составил $52,2 \pm 1,14$ года, возрастной диапазон – от 21 до 72 года.

Для стадирования опухолевого процесса мы использовали международную классификацию по системе TNM (1987). III стадия заболевания выявлена у 6 больных (6,0%) и IV – у 94 (94,0%). Локализация первичной опухоли в желудке была следующей: нижняя треть – у 15 больных, средняя треть – у 25, верхняя треть – 11, тотальное поражение – у 37 и опухоль, выходящая за пределы одного органа у 11. Выход опухоли на серозную оболочку желудка (T3) выявлен у 59 больных, прорастание в соседние органы (T4) – у 29, опухоль не выходила за пределы стенки желудка (T2) у 11 больных; случай поражения только слизистой (T1) было в одном случае. Наличие метастазов в регионарных лимфатических узлах было подтверждено морфологическим методом у 91 больных. Паллиативный характер операции был обусловлен наличием отдаленных метастазов у 96 (96,0%) больных: гематогенных у 15 (15,0%), диссеминации по брюшине у 29 (29,0%), лимфогенных у 64 (64,0%).

Макроскопически в 88% наблюдений опухоль соответствовала III-IV типу по классификации Borrmann (1926). По морфологическому строению большинство опухолей было представлено низкодифференцированной аденокарциномой – 72%.

Всем больным произведена оперативное вмешательство в объеме гастрэктомии. Чрезбрюшинный доступ применен у 92 больных, левосторонний торакоабдоминальный – у 8. Операции в стандартном объеме выполнены у 41 больным, расширенно-комбинированные – 59. При выполнении комбинированных операций наиболее часто производили спленэктомию (30 больных), резекцию поджелудочной железы (13), печени (9), нижнегрудного отдела пищевода (8), толстой кишки (5), диафрагмы (4), тонкой кишки (2), удаление яичников (2), иссечение пупка (1), резекция надпочечника (1). У 23 больных был резецирован/удален один орган, у 17 – два и у 3 – три органа. При выявлении отдаленных метастазов в брюшной полости проводили максимальное удаление их за счет расширения оперативного вмешательства на путях лимфооттока, резекции смежных органов.

Результаты и их обсуждение

Из 100 больных, оперированных по поводу рака желудка в объеме паллиативной гастрэктомии, послеоперационный период протекал без осложнений у 72 ($72,0 \pm 4,5\%$), имелись те или иные осложнения у 28 больного ($28,0 \pm 4,5\%$).

Наши данные о характере осложнений в зависимости от объема оперативных вмешательств представлена в

Таблица 1 - Структура осложнений у больных раком желудка после паллиативных гастрэктомий в зависимости от объема операции

Осложнения	Стандартная (n=41)		Расширен., комбинирован. (n=59)	
	Кол-во	Летальн.	Кол-во	Летальн.
Несостоятельность швов анастомозов	2 (4,9%)	1(2,4%)	1 (1,7%)	1(1,7%)
Тромбоз брыжеечных сосудов с исходом в некроз кишечника	-	-	2 (3,4%)	1(1,7%)
Панкреатит и панкреонекроз	-	-	2 (3,4%)	-
Перитонит, абсцесс без несостоятельности	-	-	4 (6,8%)	1 (1,7%)
Свищи (тонко и толстокиш.)	-	-	3 (5,2%)	1(1,7%)
Нагноение раны, эвентрация	1 (2,4%)	-	4 (6,8%)	1(1,7%)
Кишечная непроходимость	-	-	2 (3,4%)	-
Анастомозит	1 (2,4%)	-	3 (5,1%)	-
Плеврит, пневмония	3 (7,3%)	-	8 (13,6%)	-
Сердечно-сосудистая недостаточность	-	-	2 (3,4%)	2(3,4%)
Нарушение мозгового кровообращения	-	-	2 (3,4%)	2 (3,4%)
Всего	7 (17,1%)	1(2,4%)	3 (55,9%)	9 (15,3%)

Таблица 2 - Структура послеоперационных осложнений у больных после паллиативных гастрэктомий при различных объемах оперативного вмешательства

Стандартные (n=59)				Расширенные (n=41)			
Стандартные (n=41)		Комбинир. (n=18)		Стандартные (n=12)		Комбинир. (n=29)	
абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
8	19,5	6	33,3	5	41,6	9	31,0
Всего		14 (23,7%±5,5)		14 (34,1%±7,4)			

таблице 1.

Заметим, что у 100 оперированных больных диагностировано по два и более осложнения. Этим объясняется несоответствие между числом больных с осложнениями и количеством осложнений. Из таблицы видно, что наиболее многочисленна группа воспалительно-гнойных осложнений, реже наблюдается различные нарушения центрального и периферического кровообращения. К третьей группе относятся тяжелые осложнения, сопровождающиеся образованием тонко- и толстокишечных свищей и развитием перитонита.

Зависимость послеоперационных осложнений от объема оперативных вмешательств при паллиативных гастрэктомиях в наших наблюдениях представлена в следующем виде: при стандартных гастрэктомиях осложнения наблюдаются в 23,7%±5,5, а при расширенных – 34,1%±7,4 (табл. 2). Из представленных данных видно, что существенной разницы в частоте осложнений после стандартных и расширенных операций практически не выявлено.

Из 100 оперированных больных умерли 8, послеоперационная летальность составила 8,0%. Отметим, что послеоперационная летальность при паллиативных гастрэктомиях существенно не отличается от послеоперационной летальности радикально оперированных больных. Причинами летальных исходов в половине случаев явились хирургические осложнения в виде перитонитов различной этиологии; у части больных перитонит развивается вследствие ограниченного гнойного процесса в брюшной полости, нарушения трофики кишечника, кишечной непроходимости, в других в связи с недостаточностью швов, накладываемых при формировании анастомозов.

В остальных случаях причиной смерти явились функциональные осложнения в виде сердечно-сосудистой недостаточности и нарушения мозгового кровообращения (табл. 1).

Летальность после стандартных паллиативных гастрэктомий составила 4,9±3,4%, а после расширенно-комбинированных – 10,2±3,9% (p>0,05) (табл. 3). Анализируя эти данные, можно сказать, что расширенно-комбинированные операции не сопровождаются увеличением послеоперационной летальности по сравнению со стандартными гастрэктомиями.

Такими образом, стандартные и расширенно-комбинированные паллиативные гастрэктомии не увеличивают частоту послеоперационных осложнений и летальность, не изменяют их структуру, что и делает оправданным выполнение таких операций в условиях специализированных клиник.

Список литературы

1. Войновский Е.А., Ефименко Н.А., Сахаров А.И. // Материалы I Съезда онкологов стран СНГ.-М., 1996.-Ч.1.-С.304.

Таблица 3 - Послеоперационная летальность больных раком желудка после паллиативной гастрэктомии в зависимости от объема операции

Операции	Кол-во (n)	Умерли из числа больных с осложнениями (n)	Летальн. (%)
Стандартные	41	2	4,9±3,4
Расширенно-комбинированные	59	6	10,2±3,9
Всего	100	8	8,0±2,7

2. Галстян А.М. и соавт. // Материалы I Съезда онкологов стран СНГ.-М.,-1996.-Ч.1.-С.305.

3. Давыдов М.И. и соавт. К вопросу о роли хирургии в лечении местно-распространенного и диссеминированного рака желудка // Анналы хирургии.- 2002.-№2.-С. 33-41.

4. Давыдов М.И., Баймухамедов А.А., Стилиди И.С. и др. // Анналы хирургии.-1997.- №3.-С.46-49.

5. Давыдов М.И. и соавт. // Материалы I Съезда онкологов стран СНГ.-М.,-1996.-Ч.1.-С.306.

6. Звездин В.П. Паллиативные гастрэктомии в лечении рака желудка: Автореф. дис. канд. мед. наук.-М., 1982.

7. Кошуг Г.Д., Катринич В.П., Донская А.Е. // Материалы I Съезда онкологов стран СНГ.-М.,-1996.-Ч.1.-С.315.

8. Куликов Е.П., Бубликов И.Д., Головкин Е.Ю., Судakov И.Б., Зубарева Т.П. // Палл. медицина и реабилитация.-2002.-№2-3.-С.75.

9. Скоропад В.Ю., Бердов Б.А. Хирургическое лечение распространенного рака желудка // Хирургия.-2004.-№11.-С. 30-35.

10. Черноусов А.Ф., Поликарпов С.А., Черноусов Ф.А. Хирургия рака желудка.- М., 2004.

11. Сигал М.З., Ахметзянов Ф.Ш. Гастрэктомия и резекция желудка по поводу рака.-Казань.1987.

12. Clark J.L., Saenz R.H., Nava H.R., Douglass H.O Jr. // Am Surg.- 1991-Vol. 57, N 8. - P. 496-501.

13. Kunisaki C. et. al. // Hepatogastroenterology.-2005-Vol. 52, N 61.- P.314-318.

14. Lehnert T, Buhl K, Dueck M, Hinz U, Herfarth C. // Eur J Surg Oncol.- 2000-Vol. 26, N 8. - P. 780-784.

15. Ohashi M, et. al. // Gan To Kagaku Ryoho.- 2004-Vol. 31, N 11. - P. 1891-93.

16. Ouchi K, et. al. // J Surg Oncol.-Vol. 69, N 1. - P. 41-44.

17. Vickery CW, Blazeby JM, Conroy T, Johnson CD, Alderson D. // Br J Surg.- 2000-Vol. 87, N 3.-P.-362-373.